11.8.1. 유행성감염병 대량발생 시 관리

제 정 일	2014.04.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	감염관리실				
유 관 부 서					

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 11.8 유행성 감염병 관리체계 JCI Standard 7th Edition: PCI.12, 12.1, 12.2

제1조 (목적)

1. 감염병과 관련된 국가재난상황, 유행발생과 같은 응급상황에 신속한 대응을 통해 감염전파를 최소화하기 위함이다.
   1) 감염성질환자의 진료를 안전하게 진행함으로써 원내 이차 감염환자 발생을 방지한다.
   2) 의료인의 노출을 최소화하여 감염노출기회를 최소화한다.
   3) 지역사회 및 정부 보건의료체계와 상호협력관계 구축을 통한 국가적 차원의 효율적 진료에 기여한다.

제2조 (정의)

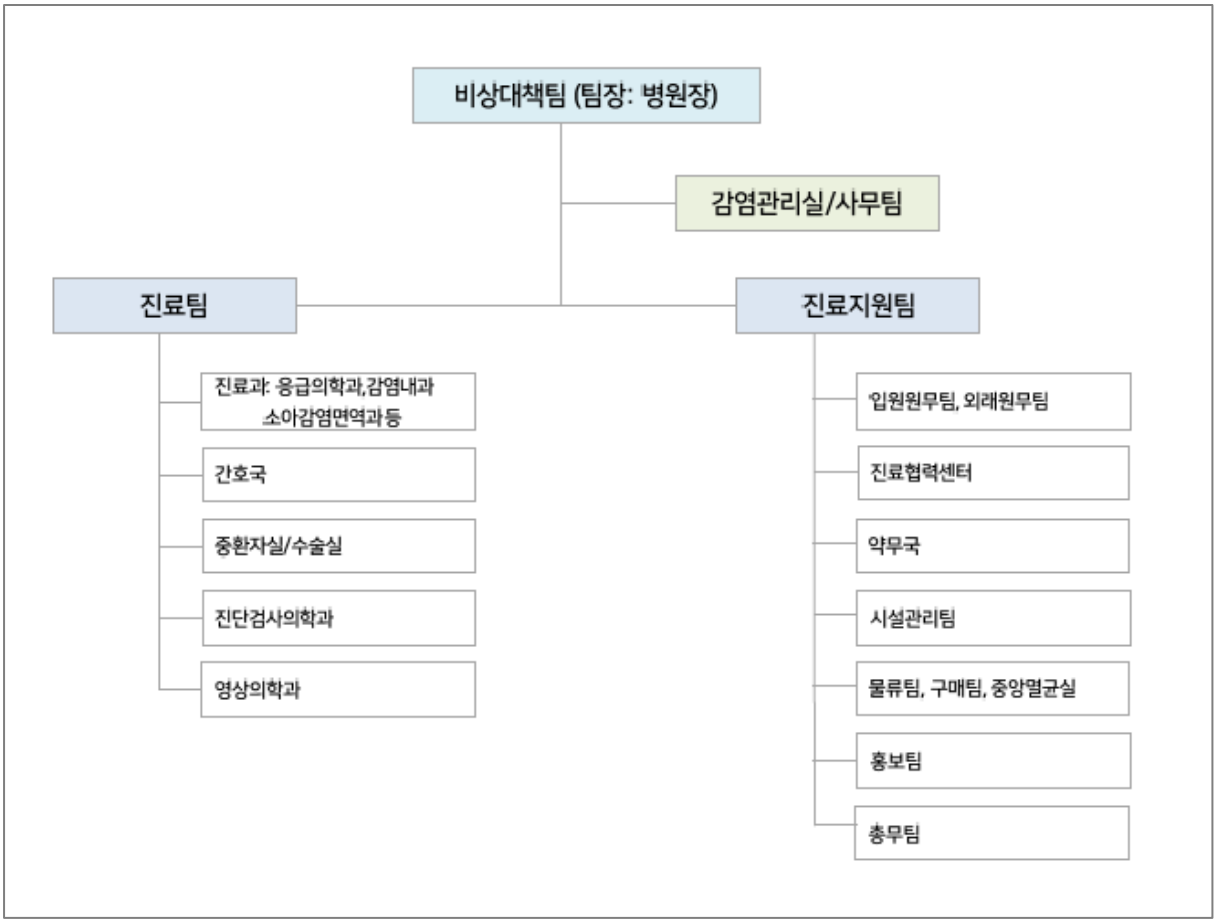
1. 감염병 위기경보 수준: 질병관리청에서 국내외 신종/재출현 감염병의 국내 유입 및 확산 상태를 참고하여 결정하며, Level 0에서 Level IV 단계로 구분한다.
2. 감염병 대상: 호흡기를 통한 감염의 우려가 있는 감염병(이하 "호흡기 감염병") 및 제1급 감염병의 경우이다.
3. Level D: 질병관리청 및 본원 내부 지침에 따라 감염병 대응 시 적용하는 개인보호구의 등급 기준 중 하나로 가장 낮은 단계에 해당한다. 전신 보호복, N95 동급의 호흡기 보호구, 장갑, 보안경 또는 안면보호구, 신발 덮개 등이 포함된다.

제3조 (절차)

1. 유행성 감염병 발생 인식을 위한 경보 체계
   1) 감염관리실은 국내 및 국외의 감염성질환의 대량발생에 대한 동향 파악 및 정부와의 긴밀한 정보교류를 위하여 질병관리청(http://www.kdca.go.kr)의 상황을 최소 주 단위로 파악하고 필요 시 원내 공지한다.
   2) 접수 및 진료단계에서 해외 여행력과 해당 감염증상이 파악되면 감염진료팀(감염내과, 응급의학과, 소아감염면역과, 소아응급의학과)과 감염관리실(감염관리실장, 감염관리팀장, 감염관리팀 파트장)에게 연락하고 신종감염병 CP(Critical Pathway) 진행과정에 따라 응급진료센터 격리구역으로 이동시켜 초기 평가를 진행한다.
   3) 위기경보단계별 대응체계는 보건복지부의 위기경보수준인 관심(Blue)-주의(Yellow)-경계(Orange)-심각(Red) 4단계에 따라 Level 0에서 Level Ⅳ로 구분하여 진행한다.

2. 감염비상대책팀 운영

1) 신종감염병 혹은 감염성질환 대량발생으로 판단되면 신종감염병 CP(Critical Pathway)를 활성화시킨다. (CP 활성화 가능자: 감염내과장/응급의학과장/감염관리실장)
2) 감염관리실은 병원장실과 연락하여 '감염비상대책팀'을 소집하고 신종감염병 및 감염성질환 대량발생 시 관리계획에 따라 진행한다.
3) '감염비상대책팀'의 장은 세브란스병원장 혹은 세브란스병원장으로부터 권한을 위임받은 사람이 진행하며, 감염관리실과 관련 부서들로 구성하고[그림1] 각 팀별 주요 역할은 [부록1. 신종감염병 대응 매뉴얼]에 따라 진행한다.
4) 신종감염병 및 감염성질환 대량 유행발생과 관련된 주요 정책들은 감염비상대책팀에서 논의하여 결정한다.
5) 지역사회 보건의료체계와의 보고체계를 확립하고 긴밀한 관계를 유지한다. 국가정책을 준수하면서 원내 감염관리를 준비한다.
6) 외부와의 공중관계는 비상대책위원회를 통해 홍보팀에서 담당하며 통로를 일원화한다.



[그림 1. 감염비상대책팀 구성]

3. 진료공간 및 진료 인력

1) 신종감염병 확인을 위한 진료는 응급진료센터 격리구역 내 음압격리실에서 감염내과, 응급의학과 및 소아청소년과(소아감염면역과, 소아응급의학과)의 별도의 훈련된 인력이 진행한다.
2) 신종감염병 의심환자 발생 시 진행내용은 신종감염병 대응 매뉴얼에 따라 진행한다.
3) 의심환자로 확인되면 국가지정 입원치료병상으로 이송한다. 이송이 불가피한 상황에서는

확인될 때까지 응급진료센터 내 격리공간을 활용하며, 결과에 따라 음압격리병실이나 일반 병동으로 이동한다. 환자 이동 시 직원과 환자는 적절한 개인보호구를 착용하고 동선통제가 필요하다.

4) 진료에 투입되는 인력(의사 및 간호사)은 매년 Level D 수준 이상의 개인보호구와 PAPR(Powered Air Purifying Respirator) 및 N95 respirator사용에 대한 훈련을 받고, 진료투입 전 관련 개인보호구에 대한 교육과 훈련을 추가로 받는다.

5) 추가 발생규모에 따른 공간 확대 및 추가 인력에 대한 결정은 감염비상대책팀의 결정에 따른다.

4. 신종감염병 대응체계 점검 및 재난훈련

1) 감염질환 비상대책계획은 감염성질환의 특성을 고려하여 매년 수정 검토하여 연초 '안전보건관리위원회'에서 최종 검토한다.

2) 비상대책계획은 매년 도상훈련(Tabletop exercise)이나 모의훈련(Drill)으로 평가하고, 개선사항 및 수행결과 등을 관련 부서와 공유하고 감염관리위원회에 보고한다. 필요시 국가기관을 포함한다.

3) 평가결과를 반영하여 비상대책계획은 매년 개정한다.

5. 감염관리원칙 준수

1) 지침에 따라 개인보호구의 착 · 탈의, 손위생을 철저히 실시한다.

2) 필요한 물품은 충분히 공급하고 관리한다.

3) 감염노출을 최소화하기 위해 의료인의 노출은 최소화한다.

4) 진료과정과 환자 이동동선은 최대한 짧게 구성한다.

5) 의심환자와 확진환자의 진료공간을 구분하여 운영한다.

6) 격리해제 기준은 질병관리청의 지침과 감염비상대책팀의 결정에 따라 진행한다.

7) 방사선 촬영 등 검사는 가능한 폐쇄된 격리 병동 내의 이동식 장비를 이용한다.

8) 감염성질환에 따라 보호자의 출입은 제한할 수 있다.

9) 의심환자와 확진환자 진료공간의 환경소독, 의료폐기물 및 세탁물 관리지침을 엄격히 준수한다.

6. 기타 자세한 내용은 신종감염병 대응 매뉴얼에 따른다.

제4조 (부록)

1. 신종감염병 대응 매뉴얼
2. 감염관리지침

제5조 (참고)

1. 대한의료관련감염관리학회. 의료기관의 감염관리. 한미의학, 2017.
2. 보건복지부. 감염병 재난 위기관리 표준매뉴얼. 2019.
3. 질병관리청. http://www.kdca.go.kr
4. 질병관리청. 국가지정 입원치료병상 운영과 관리지침. 2024.

내규의 제 · 개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)

1. 이 내규는 2014년 4월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인: 세브란스병원장 이 강 영 (인)